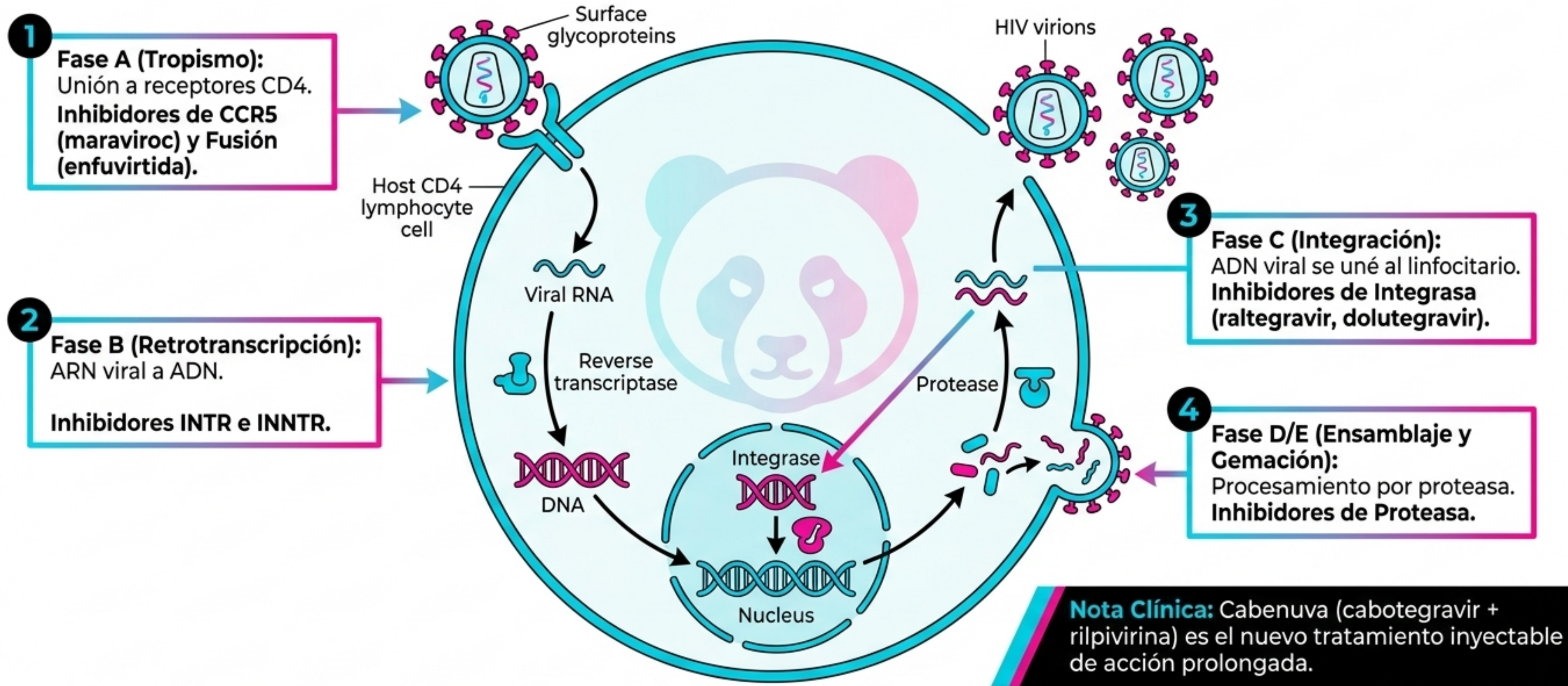


Infecciones Oportunistas y Terapia Antirretroviral (TARGA) en VIH/SIDA

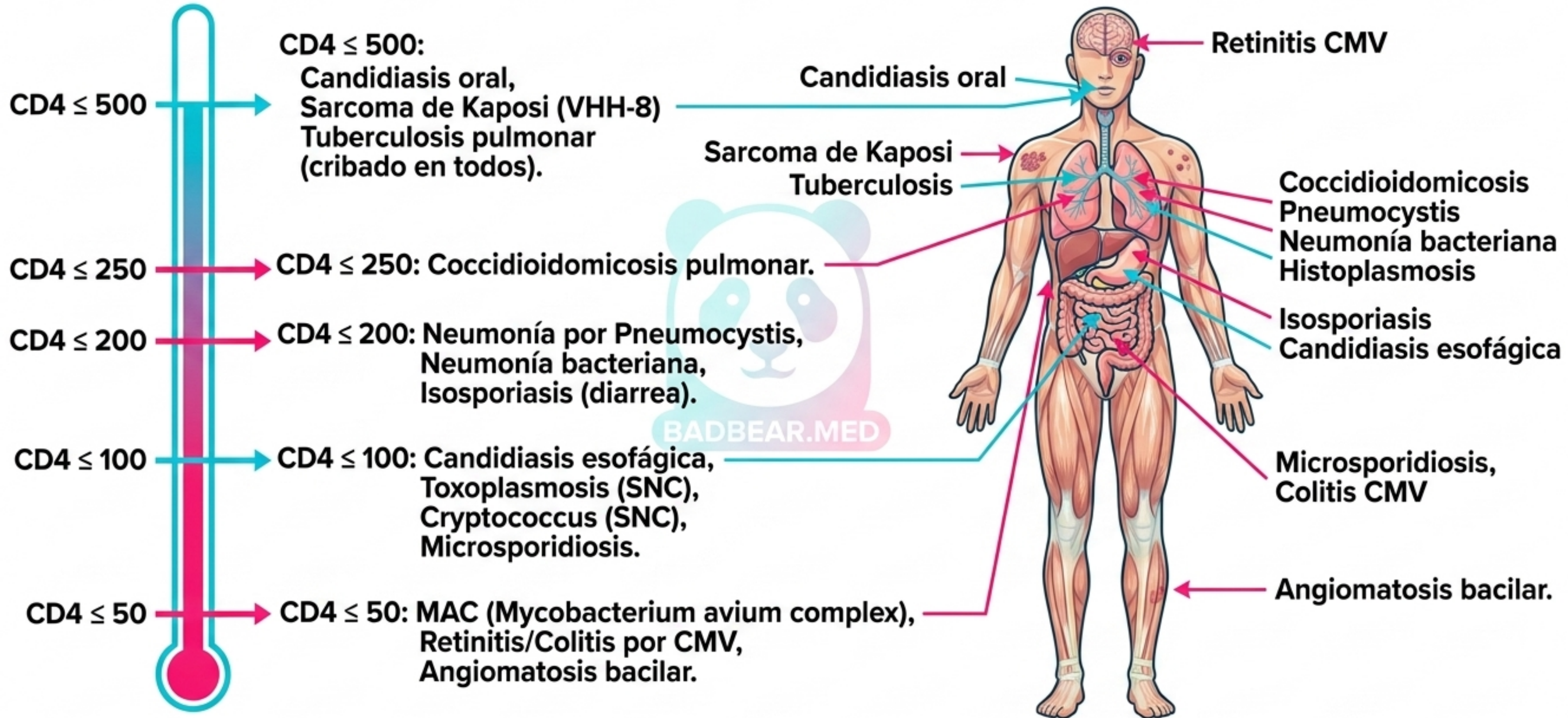


Guía de Estudio Estructurada

Ciclo Vital del VIH y Dianas Terapéuticas



El Reloj Inmunológico: Infecciones Oportunistas por Nivel de CD4



Matriz de Manejo I: Infecciones Gastrointestinales y Pulmonares

Condición	Tratamiento / Manejo
Diarrea Crónica	Empírico con TMP/SMX. Si no hay respuesta: Ciprofloxacina 500mg c/12h x 5 días.
Microsporidiosis	Albendazol 400mg c/12h x 4 semanas.
Cystoisosporiasis	TMP/SMX 160/800mg c/6h o 2 tab c/12h x 10 días.
Neumocistosis (Pneumocystis jirovecii)	Casos leves/moderados: TMP/SMX. Casos severos ($pO_2 < 70\text{mmHg}$): Agregar Prednisona. Alternativa alérgicos: Dapsona o Primaquina + Clindamicina.
Neumonía Bacteriana	Ambulatorio: Amoxicilina/Ácido Clavulánico + Claritromicina. Hospitalizado: Ceftriaxona + Claritromicina.

Matriz de Manejo II: Infecciones Neurológicas y Sistémicas

Condición	Tratamiento / Manejo
Toxoplasmosis (SNC)	Pirimetamina 200mg (ataque) luego 75mg + Clindamicina + Ácido folínico. Alternativa: TMP/SMX + Clindamicina. Corticoides solo si hay efecto de masa.
Neurocriptococosis	Inducción con Anfotericina B liposomal + Fluconazol 800mg x 2-4 semanas. Consolidación: Fluconazol 450mg x 8 semanas.
Enfermedad por CMV (Retinitis/Esofagitis)	Ganciclovir 5mg/kg IV c/12h x 21 días o Valganciclovir 900mg VO c/12h.
Sarcoma de Kaposi	Iniciar o optimizar el TARGA . Derivar a oncología.

Principios del TARGA (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad)

Objetivo Principal

Reducir la carga viral a niveles indetectables por el mayor tiempo posible.

Debe constar de por lo menos 3 drogas de 2 clases diferentes.

Criterios de Inicio

Se inicia en toda persona con infección por VIH.

Es independiente del estadio clínico, recuento de CD4 o carga viral.

El inicio debe ser en el plazo más corto posible.

BADBEAR.MED

Requisitos Basales

Hemograma completo, TGP, Glucosa en ayunas, Creatinina sérica.

Radiografía de tórax, Baciloscopía (descarte TB), Descarte de ITS (VHB, VHC, Sífilis).

Recuento basal de CD4 y Carga Viral (CV).

Esquemas de Primera Línea

Esquema de Elección (Dosis Fija Combinada)

Tenofovir (TDF) 300mg + Lamivudina (3TC) 300mg + Dolutegravir (DTG) 50mg.

Dosis: 1 tableta cada 24 horas.

Esquemas Alternativos (Si hay contraindicación/eventos adversos a DTG)

Tenofovir (TDF) 300mg + Lamivudina (3TC) 300mg + Efavirenz (EFV) 400mg.

Tenofovir (TDF) 300mg + Emtricitabina (FTC) 200mg + Efavirenz (EFV) 600mg.

Dosis: 1 tableta cada 24 horas.

Profilaxis Post-Exposición (PEP)

Exposición Ocupacional	Exposición No Ocupacional
Personal de salud, lesión percutánea o mucosas con fuente VIH+.	Fluidos potencialmente contaminados fuera del trabajo.
Esquema Principal (Ambos Casos)	
TDF/3TC/DTG (1 tableta c/24h) por un periodo exacto de 4 semanas.	
Esquema Alternativo	
TDF/FTC (1 tab/24h) + Darunavir 800mg/Ritonavir 100mg (1 tab/24h) por 4 semanas. (Lopinavir/Ritonavir 200/50mg se usará solo ante no disponibilidad de esquemas anteriores).	

Farmacología I: INTR (Inhib. Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa)

Fármacos:

Zidovudina (AZT), Lamivudina (3TC), Estavudina (d4T), Didanosina (ddI), Abacavir (ABC), Emtricitabina (FTC), Tenofovir (TDF).

Características de Clase:

Se toman con o sin alimentos (excepto ddI: en ayunas).
Riesgo de condición rara pero fatal: Acidosis láctica y esteatosis hepática.

Toxicidades Específicas: **BADBEAR.MED**

- Zidovudina (AZT): Anemia severa, neutropenia, miopatía.
- Estavudina (d4T): Neuropatía periférica (hormigueos/calambres).
- Didanosina (ddI): Pancreatitis.



Farmacología II: INNTR (Inhib. No Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa)

Fármacos: Nevirapina (NVP), Efavirenz (EFV), Delavirdina.

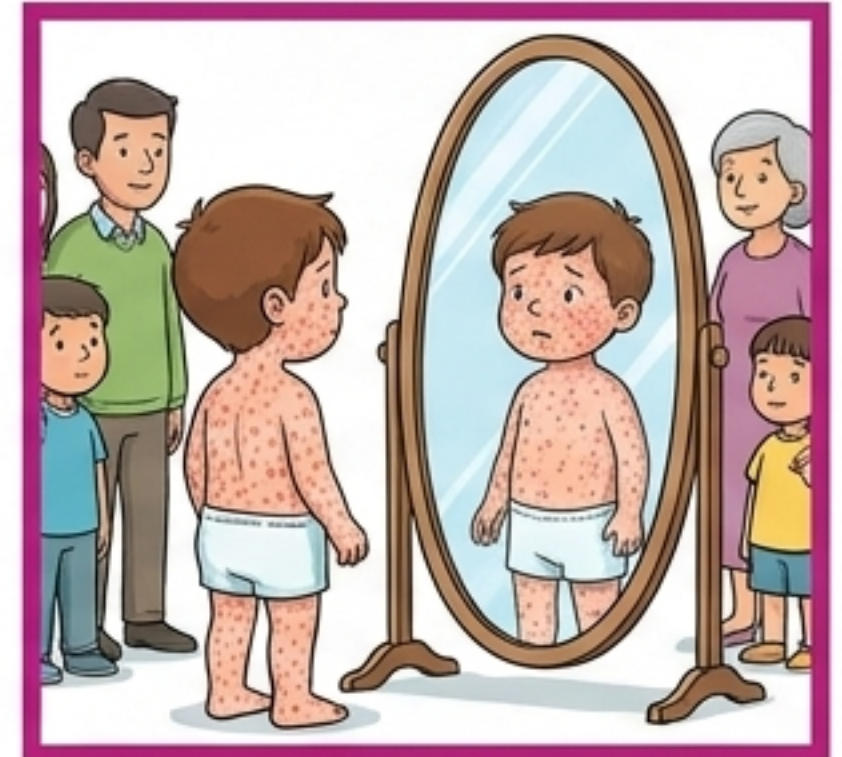
Alerta de Clase: Alta incidencia de RASH, que puede llegar a ser muy severo.

Nevirapina (NVP): El rash es común tempranamente.

Estrategia: Iniciar con **1 tableta** al día por los primeros **14 días**, luego subir a **dosis plena** (2v/día).

BADBEAR.MED

Efavirenz (EFV): Efectos colaterales del Sistema Nervioso Central. Produce **mareos**, **cefalea**, **insomnio**, dificultad para **concentrarse** y **pesadillas vívidas** (se recomienda dosificar en las noches).



Farmacología III: IP (Inhibidores de Proteasa)

Fármacos: Lopinavir/Ritonavir (Kaletra), Indinavir, Nelfinavir, Saquinavir, Atazanavir, Amprenavir.

Tolerancia: Principal evento adverso temprano es la intolerancia gastrointestinal (especialmente diarrea severa con LPV/r).

Caos Metabólico

- **Hiperglicemia** y **Resistencia a la Insulina:** Todos los IP interfieren en la captación de glucosa (**Indinavir** es el más asociado).
- **Hiperlipidemias:** Aumento profundo de triglicéridos (LPV/r) y colesterol (IDV/RTV).
- **Recomendación:** Glucosa basal, a los 3-6 meses, y luego anualmente.

Matriz de Toxicidad Severa: Órganos Diana



Toxicidad Mitocondrial (Acidosis Láctica)

Inducida principalmente por INTRs:
d4T, ddI, AZT.

Afecta páncreas, músculo
esquelético, tejido adiposo.

Asintomático: Lactato 2-5 mmol/L.

Sintomático: Lactato >5 mmol/L
(Náuseas, dolor abdominal,
hepatomegalia, arritmias).

Grave: Lactato > 10 mmol/L.



Hepatotoxicidad

Incremento de transaminasas.

Grado 1: Aumento hasta 2.5 veces
el límite normal.

Grado 2: Hasta 5 veces.

Grado 3: Hasta 10 veces.

Grado 4: Aumento mayor a 10
veces.

Alteraciones Metabólicas: Síndrome de Lipodistrofia

Concepto: Cambios severos en la distribución de la grasa corporal. Afecta drásticamente la calidad de vida y adherencia. Pueden coexistir en un mismo paciente.

Lipoatrofia (Pérdida de Grasa)

- **Zonas:** Cara (bichat), extremidades, pared abdominal.
- **Causas:** INTRs (d4T, AZT).
- **Riesgos:** Edad >40, IMC bajo, enfermedad avanzada.

Lipohipertrofia (Ganancia de Grasa)

- **Zonas:** Dorso-cervical (Giba de búfalo), pared abdominal/peritoneal, glándulas mamarias, parótidas.
- **Causas:** Inhibidores de Proteasa (IPs).
- **Riesgos:** Mujeres, IMC >25, Edad >35.

Diagnóstico Clínico de Lipodistrofia



Lipoatrofia facial severa
(hundimiento de mejillas).

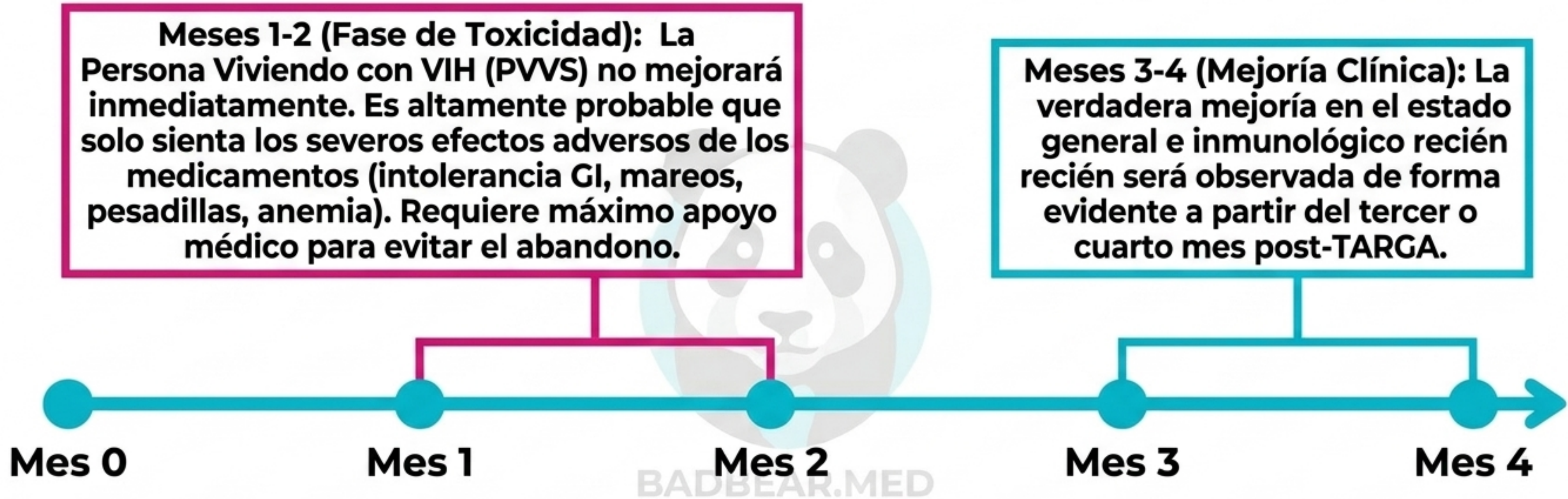


Lipohipertrofia dorso-cervical
y abdominal severa.

Criterios Diagnósticos:

- Altamente **subjetivo**; percibido **tempranamente** por el paciente o su familia.
- Difícil de **cuantificar** con laboratorios.
- El diagnóstico y seguimiento se apoya fuertemente en la **Antropometría seriada**.

Perlas Clínicas y Pronóstico del Paciente



Mantener la adherencia es el pilar de la supervivencia.